

Quando o pé diabético evolui para sepse

O que a família precisa saber e fazer agora

A sepse é a reação do corpo a uma infecção que saiu do lugar. Quando a ferida do pé diabético deixa de ser uma infecção local e passa a ser sistêmica, as bactérias e as toxinas que elas produzem caem na corrente sanguínea, e o corpo entra numa espécie de tempestade inflamatória que começa a derrubar os órgãos um a um — coração, pulmão, rim, cérebro, fígado. Isso acontece em **horas**, não em dias. É por essa razão que, dentro da medicina, sepse é tratada como emergência do mesmo nível que infarto e AVC.

No caso específico de alguém com pé diabético extenso, diabetes de longa data e rim funcionando a 14%, o risco é maior por três motivos. O diabetes já enfraquece o sistema imune, então o corpo reage pior à infecção. O rim quase parou — e é justamente ele que tira do sangue as toxinas que a infecção produz, então elas se acumulam rápido. E muitos diabéticos, com o tempo, **perdem a capacidade de ter febre alta** por causa de uma alteração nos nervos chamada neuropatia autonômica. Isso é traiçoeiro: a pessoa pode estar entrando em sepse com temperatura de 37,2 ou 37,5 — ou até temperatura normal — e a família pensa “não está tão mal”. Está.

Os sinais que precisam disparar o alarme

Não é preciso ser médico para reconhecer sepse. São sete sinais principais, e **qualquer um deles isoladamente** já é motivo para pronto-socorro imediato:

- **Confusão, sonolência fora do normal, dificuldade de acordar ou fala arrastada.** Esse é o sinal mais importante e o mais ignorado. Quando o cérebro começa a ser afetado, a pessoa fica “estranha”, desorientada, responde devagar, troca nomes, não reconhece bem onde está. Familiares frequentemente atribuem isso a cansaço ou idade. Não é.
- **Respiração rápida**, como se estivesse cansado sem ter feito esforço. Se dá para contar mais de 22 respirações por minuto em repouso, é alerta.
- **Coração acelerado** mesmo deitado, em geral acima de 100 batimentos por minuto.
- **Pressão caindo** — tontura ao levantar, sensação de desmaio, pele fria e suada.
- **Calafrios e tremores incontroláveis**, mesmo sem febre alta.
- **Pele marmoreada** (desenho roxo-azulado, como mármore), extremidades frias, lábios ou pontas dos dedos arroxeados.
- **Diminuição ou ausência de urina.** Em quem já tem o rim falhando isso é mais difícil de perceber, mas vale prestar atenção se o xixi sumiu de vez.

A própria ferida também dá pistas. Se apareceu cheiro muito forte, pútrido ou adocicado; se a pele ao redor está vermelha e inchada e essa vermelhidão está **subindo pela perna** em direção ao joelho; se surgiu pus em grande quantidade; se aparecem bolhas escuras, manchas pretas novas ou áreas que antes não existiam; se ao tocar a pele se sente crepitação (uma sensação de estouro, como plástico bolha) — qualquer um desses é indício de infecção grave, possivelmente necrosante, que é

uma forma agressiva que se espalha em horas.

O que fazer agora

Se houver suspeita de sepse, o caminho **não é** marcar consulta com o nefrologista, **não é** esperar a próxima avaliação do cirurgião vascular, **não é** fazer curativo em casa. É ir ao pronto-socorro de um hospital que tenha UTI e cirurgia vascular — nessa ordem de prioridade. Se a cidade tem um hospital de referência no SUS, é para lá. Se tem hospital universitário, melhor ainda. Se ele não tem condições de ser levado em carro particular (pressão baixa, confusão, respiração difícil), SAMU (192).

Na triagem do pronto-socorro, dizer com essas palavras: **“ele tem pé diabético infectado, rim em 14% e está com sinais de sepse”**. Essas três informações juntas — pé diabético, sepse, insuficiência renal — movem o paciente para a frente da fila. Não é exagero; é a descrição clínica correta. Triagens de emergência usam protocolos (Manchester e similares) que priorizam exatamente esse quadro.

O que levar para o hospital

Qualquer coisa que economize tempo nas primeiras horas faz diferença. Pasta ou caderno com os exames mais recentes — principalmente creatinina, ureia, potássio, hemoglobina e hemograma. Lista completa de medicamentos com dose e horário. Nomes, telefones e CRM dos médicos que o acompanham (nefrologista, endocrinologista, vascular). Documento de identidade, cartão do SUS ou do plano. Se alguém tiver fotos da evolução da ferida no celular, levar também — ajuda a equipe a entender se piorou rápido ou devagar.

O que vai acontecer no hospital

Saber o que esperar acalma. Nas primeiras horas, vão coletar sangue para hemocultura (identificar a bactéria que está circulando), pedir raio-X ou tomografia do pé para ver se a infecção chegou ao osso (osteomielite), e fazer exames completos para medir lactato (marcador de gravidade da sepse), função renal, eletrólitos e inflamação. Vão iniciar antibiótico endovenoso de amplo espectro — a recomendação internacional é que esse antibiótico entre na veia **dentro da primeira hora** após a suspeita de sepse, porque cada hora de atraso aumenta a mortalidade em cerca de 7 a 8%.

Também vão administrar soro para tentar estabilizar a pressão, mas com cuidado, porque o rim não elimina bem — e nesses casos o soro às vezes precisa ser contrabalançado com diálise de urgência para retirar o excesso de líquido. É muito provável que ele vá para a UTI. E é provável que o cirurgião vascular ou ortopédico seja chamado para avaliar se o pé precisa de desbridamento cirúrgico (limpeza profunda) ou, em casos mais graves, amputação imediata como medida para salvar a vida.

Sobre a amputação — uma conversa difícil

Quando a infecção no pé virou a fonte de uma sepse, muitas vezes a única forma de salvar o paciente é retirar o pé. Isso é duro de ouvir, e a família normalmente resiste. Vale ter clareza sobre

o seguinte: **em pé diabético séptico, a amputação precoce costuma salvar vidas; a amputação tardia, depois que a sepse já se instalou, tem resultados muito piores.** Os médicos vão pesar o risco cirúrgico (porque ele tem rim ruim e está instável), mas se a equipe indicar amputação, é porque entendeu que retirar a fonte de infecção é o caminho. Não é falha de tratamento, não é desistência — é o que a medicina chama de *cirurgia de controle de foco*, e faz parte do protocolo de tratamento da sepse.

Nesse momento vale também a família pedir uma **conversa formal com a equipe médica** — idealmente com o médico responsável, o familiar mais preparado para ouvir, e se possível alguém dos cuidados paliativos. Não para decidir desistir, mas para alinhar até onde ir, o que o paciente gostaria, como conduzir. Hospitais maiores costumam ter equipe de cuidados paliativos disponível mesmo para a UTI, e elas ajudam demais em conversas assim.

Sobre a diálise que estava em espera

Se a sepse se confirmar, a lógica de “esperar o pé melhorar para começar diálise” deixa de fazer sentido — porque o que vai ajudar o pé a melhorar agora é tirar as toxinas do sangue e manter os órgãos funcionando, e isso é exatamente o que a diálise faz. Em sepse com rim em 14%, a indicação de diálise normalmente vira de urgência, e muda o plano todo. É importante a família saber disso para não se perder na conversa do hospital: o cenário é outro.

Uma palavra final

Esse é um momento em que a família precisa estar junta e dividir tarefas, porque uma pessoa só não dá conta. Alguém acompanha no hospital, alguém anota o que os médicos falam (sério, anotar — se perde metade na emoção), alguém cuida de quem ficou em casa, alguém resolve o prático. E alguém precisa descansar. Maratona de UTI esgota o cuidador, e cuidador esgotado toma decisão ruim.

Não dá para prometer que vai dar tudo certo, e seria desonesto dizer isso. O quadro é grave. Mas sepse tratada nas primeiras horas tem muito mais chance de resposta do que sepse tratada em 12 ou 24 horas. O que vocês fizerem agora faz diferença real.